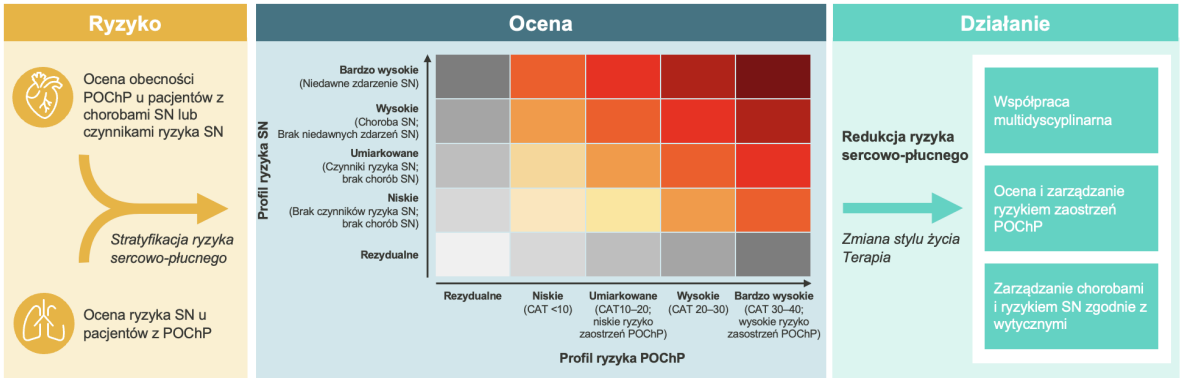
OCENA RYZYKA SERCOWO-PŁUCNEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ

Często pomijanym czynnikiem występowania chorób sercowo-naczyniowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Istnieją znane powiązania epidemiologiczne między występowaniem POChP, a chorobą niedokrwienną serca, czy niewydolnością serca, przez co należy poszerzyć czujność kardiologiczną wśród pacjentów zmagających się z tym schorzeniem. W 2025 r. ukazało się stanowisko międzynarodowej grupy ekspertów (Global Working Group on Cardiopulmonary Risk) dotyczące identyfikacji i zarządzania ryzykiem sercowo-płucnym u pacjentów z POChP. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, w ramach wizyty podsumowującej powinna odbyć się również ocena ryzyka sercowo-płucnego pacjenta.

Ze względu na brak uwzględnienia POChP jako czynnika ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w dotychczasowo używanych algorytmach (np. SCORE2, QRISK3) Global Working Group on Cardiopulmonary Risk utworzyła nowe narzędzie do oceny ryzyka sercowo-płucnego, gdzie definiowane jest ono jako ryzyko wystąpienia zdarzeń dotyczących zarówno układu krążenia, jak i układu oddechowego.



Grafika zaadaptowana na podstawie: Gale CP i wsp. Eur J Prev Cardiol. 2025.

Oceniając ryzyko płucne w ramach tego schematu należy oprzeć się na wyniku z testu CAT, które jest zwalidowanym narzędziem dla Polski. Klasyfikuje się je jako **niskie**, jeśli wynik wyniósł <10, **umiarkowane**, jeśli znajdował się w zakresie 10-20, **wysokie**, jeśli znajdował się w zakresie 20-30 lub **bardzo wysokie** jeżeli znajdował się w zakresie 30-40.

Ryzyko sercowo-naczyniowe w ramach tego schematu klasyfikuje się jako **niskie**, kiedy nie występują czynniki ryzyka SN (definiowane jako wysokie ciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol nie-HDL, nikotynizm, cukrzyca, otyłość, płeć męska, wiek podeszły, obciążenie rodzinne), ani choroby SN; **umiarkowane**, kiedy występują czynniki ryzyka SN, ale nie rozpoznano choroby SN; **wysokie**, kiedy rozpoznano chorobę SN, ale w ostatnim czasie nie wystąpiły incydenty SN (definiowane jako zawał serca lub udar mózgu); **bardzo wysokie**, kiedy w ostatnim czasie wystąpił incydent SN.

OCENA RYZYKA SERCOWO-PŁUCNEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ

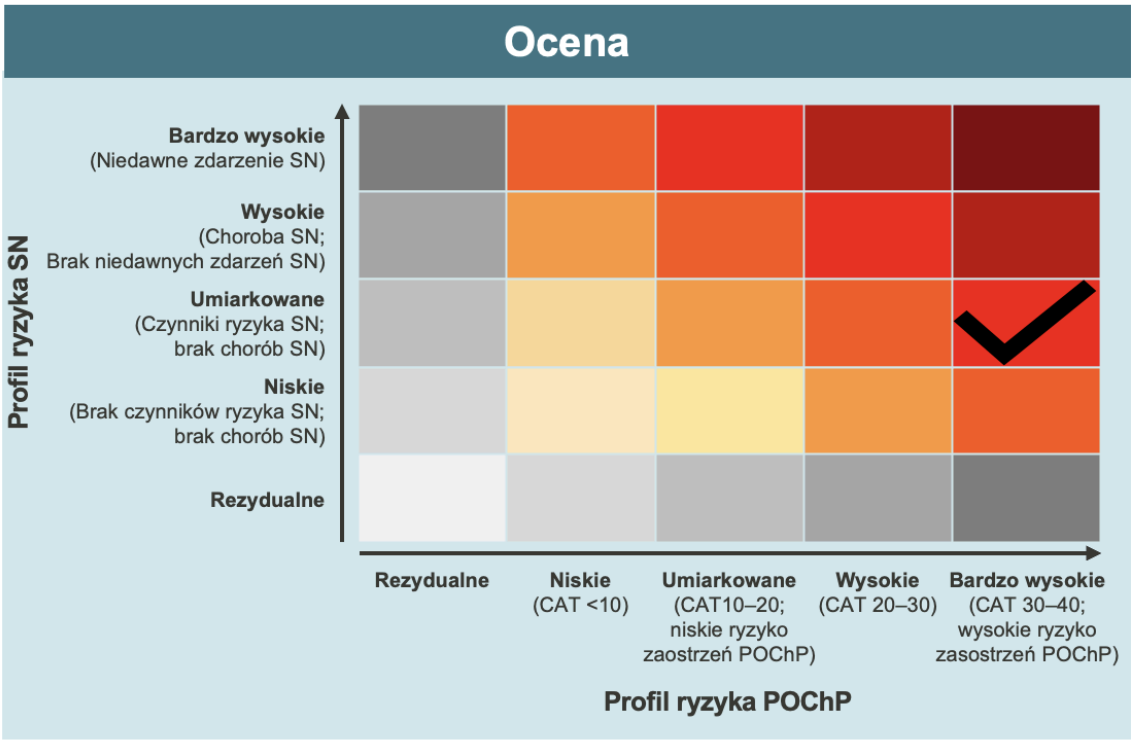
Pacjent z POChP poddany optymalnemu leczeniu pod kątem chorób sercowo-naczyniowych oraz płucnych, może nadal być narażony na podwyższone ryzyko sercowo-płucne, choć ryzyko wystąpienia zdarzeń jest mniejsze niż wcześniej. Nazywane jest ono ryzykiem rezydualnym.

W każdym wierszu należy zaznaczyć (X) pole najlepiej opisujące Pana/-i obecną sytuację.
Na każde pytanie prosimy udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Przykład: Jestem bardzo szczęśliwy/-a 0 X 2 3 4 5 Jestem bardzo smutny/-a

								WYNIK
Nigdy nie kaszlę	0	1	2	3	4	5	Kaszlę cały czas	
W ogóle nie mam plwociny (śluzu) w dolnych drogach oddechowych i płucach	0	1	2	3	4	5	Moje dolne drogi oddechowe i płuca są całkowicie wypełnione plwociną (śluzem)	
W ogóle nie odczuwam ciasnoty w klatce piersiowej	0	1	2	3	4	5	Odczuwam silną ciasnotę w klatce piersiowej	
Gdy idę pod górę lub po pokonaniu jednego biegu schodów, nie dostaję zadyszki	0	1	2	3	4	5	Gdy idę pod górę lub po pokonaniu jednego biegu schodów, dostaję silnej zadyszki	
Nie mam żadnych trudności z wykonywaniem jakichkolwiek czynności w domu	0	1	2	3	4	5	Mam bardzo duże trudności z wykonywaniem wszelkich czynności w domu	
Pomimo choroby płuc, wychodząc z domu czuję się pewnie	0	1	2	3	4	5	Ze względu na chorobę płuc, wychodząc z domu w ogóle nie czuję się pewnie	
Sypiam głębokim snem	0	1	2	3	4	5	Ze względu na chorobę płuc nie sypiam głębokim snem	
Mam dużo energii	0	1	2	3	4	5	Nie mam w ogóle energii	
							SUMA PUNKTÓW	

Po sklasyfikowaniu ryzyka sercowo-płucnego pacjenta należy odnotować to w IPZ oraz odnieść się do ryzyka sercowo-naczyniowego sklasyfikowanego według innych narzędzi np. Lipoproteina (a) lub SCORE2. Jako **globalne ryzyko sercowo naczyniowe** wybieramy to, które dla pacjenta jest najwyższe np. pacjent ma wysokie ryzyko według SCORE2, natomiast ma 30-40 punktów w skali CAT i występują u niego czynniki ryzyka, co przełoży się na bardzo wysokie ryzyko sercowo-płucne, to należy uznać globalne ryzyko sercowo-naczyniowe za bardzo wysokie.



Grafika zaadaptowana na podstawie: Gale CP i wsp. Eur J Prev Cardiol. 2025.

Należy wówczas również w sposób kompleksowy zadbać o obniżenie ryzyka zarówno ze względu na komponentę płucną jak i sercowo-naczyniową.

BIBLIOGRAFIA

1. Finkelstein J, Cha E, Scharf SM. Chronic obstructive pulmonary disease as an independent risk factor for cardiovascular morbidity. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2009;4:337-349. doi:10.2147/copd.s6400
2. Gale CP, Hurst JR, Hawkins NM, et al. Identification and management of cardiopulmonary risk in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a multidisciplinary consensus and modified Delphi study. Eur J Prev Cardiol. 2025;32(15):1445-1460. doi:10.1093/eurjpc/zwaf119
3. Farnik M, Brożek G, Czajkowska-Malinowska M, et al. Validation of the Polish-language version of the COPD Assessment Test. Pol Arch Intern Med. 2019;129(9):605-611. doi:10.20452/pamw.14929